

每週心血管期刊文獻回顧

Weekly Cardiovascular Journal Review

2026-08-08 ~ 2026-08-14

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

涵蓋期刊：NEJM | Lancet | EHJ | JACC 系列 | Circulation 系列 | EuroIntervention



每張重點投影片附 QR Code，可掃描跳轉原文 DOI

🎯 本週主題與固定欄目

看清風險的真面目——把「粗指標」換成能重新分層的細節

本週六大固定欄目：

1. ★ **Top 5 Picks** — 跨期刊精選
2. ❤️ **TAVI Section** — 結構性主動脈瓣方向
3. 🔧 **TEER Section** — 二尖瓣與三尖瓣緣對緣
4. 📚 **Honorable Mentions** — 其他值得讀
5. 🔬 **Case Reports** — 結構／冠脈介入 × 5
6. 📖 **參考文獻 + 縮寫對照**

⚠️ 本週 *Lancet* 無心血管原始研究；*NEJM* 為 VERVE-102 降 LDL 之隨附社論（原始試驗本

★ Top 5 Picks

#	研究	期刊	關鍵數字
1	WC/WHR 超越 BMI 再分層 (CCC)	JACC	n=259,388 ; 風險 +15~50%
2	性別 × 亞臨床冠狀動脈粥狀硬化	<i>Eur Heart J</i>	MI HR 女 4.1 / 男 12
3	JROADHF-NEXT (日本心衰)	<i>Eur Heart J</i>	死亡 ↓26.7%、再住院 ↓52.1%
4	BTK 抑制劑 × 缺血性 MACE	<i>Eur Heart J</i>	RR 1.66 (1.09–2.53)
5	AI-ECG 篩檢恰加斯病	<i>Circulation</i>	AUC 0.776 (n=59,154)

Pick #1

Cross-Cohort Collaboration (CCC)

腰圍／腰臀比在 BMI 之外重新分層心血管風險

Pick #1 — WC/WHR 超越 BMI (設計)

Dardari ZA, et al. (Blaha MJ 通訊) *J Am Coll Cardiol* 2026;88(6):670–684.

 DOI: [10.1016/j.jacc.2026.05.050](https://doi.org/10.1016/j.jacc.2026.05.050)

- 跨世代合作聯盟 (Cross-Cohort Collaboration, CCC) : **15 世代、259,388 人**
- 9 種終點：MI、中風、心衰、心房顫動 (Atrial Fibrillation, AF)、總冠心病、總 CVD、冠心／CVD 死亡、全因死亡
- 曝險：**腰圍 (Waist Circumference, WC)、腰臀比 (Waist-to-Hip Ratio, WHR)** (相對於 BMI)
- 中位追蹤 **20 年**



 Scan DOI

+15% ~ +50%

正常體重／過重但高 WC 或 WHR → 多數終點風險上升

肥胖者高 WC 的族群可歸因風險：心衰與 AF 最高

BMI 正常 ≠ 代謝正常：量腰圍，抓出被漏掉的中央型肥胖

Pick #1 — 臨床啟示

WC/WHR 揭示了傳統 BMI 分類的錯分，並在 BMI 之上增加診斷與預後價值

- 女性即使肥胖但低 WHR，各終點風險仍高於「正常體重且低 WHR」
- 對「BMI 正常但腹部肥胖」的亞洲『泡芙人』族群尤其重要
- **臨床操作極簡單：量腰圍**，納入常規風險評估
- 務實界限：觀察性合併分析、量測標準化不一；但 n 近 26 萬、方向一致

Pick #2

性別 × 亞臨床冠狀動脈粥狀硬化

丹麥一般人口 CCTA 世代

Pick #2 — 設計與結果

Larsen AF, et al. *Eur Heart J* 2026 Aug 12.

 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag612](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag612)

- 無症狀 >40 歲：女性 5,710、男性 4,293 做冠狀動脈電腦斷層血管攝影 (CCTA)；追蹤 6.0 年
- **各年齡層女性亞臨床粥狀硬化皆少於男性** (交互作用 $p < .0001$)

終點 (有 vs 無阻塞性亞臨床病灶)	女性 HR	男性 HR
心肌梗塞 (MI)	4.1 (1.5–11)	12 (4.6–34)
死亡或 MI	1.9	2.7
臨床驅動血運重建	23	34



 Scan DOI

Pick #2 — 臨床啟示

相同斑塊、女性 MI 風險較低；但阻塞性亞臨床病灶絕非良性

- 支持兩個看似矛盾卻並存的觀念：
 - 女性在相同斑塊負荷下 MI 較少（斑塊組成／微血管／荷爾蒙）
 - **女性一旦有阻塞性亞臨床病灶，仍有 4 倍 MI 風險**
- 對無症狀高風險族群的 CCTA 篩檢與後續 LDL 積極管理提供實證
- 務實界限：單國世代、女性事件數偏少（CI 較寬）

Pick #3

JROADHF vs JROADHF-NEXT

日本心衰竭真實世界預後在十年間顯著改善

Pick #3 — 設計與結果

Tohyama T, et al. *Eur Heart J* 2026 Aug 8.

 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag577](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag577)

- JROADHF (2013 , n=13,238) vs JROADHF-NEXT (2019-21 , n=4,016) ; 1:1 配對各 2,972
- GDMT 普及： β -阻斷劑 74.9% → 80.8%、MRA 54.2% → 61.1%
- **心臟復健 43.5% → 88.8%、營養衛教 2.9% → 56.1%**

終點	變化
1 年死亡率	↓ 26.7% (p<.001)
心衰再住院率	↓ 52.1% (p<.001)



 Scan DOI

Pick #3 — 臨床啟示

藥物救死亡、復健 + 營養 + 照護體系救再住院

- 死亡改善 ← 藥物 (RAS-I HR .71 ; β -阻斷劑 HR .85) + 營養衛教 (HR .76)
- 再住院下降 ← 主要由整體照護體系改變驅動 (次分布 HR .49)
- 對台灣心衰整合照護 (HF team、居家、復健轉介) 的有力佐證
- 務實界限：觀察性登記比較，殘餘干擾難免；配對後方向明確

Pick #4

BTK 抑制劑 × 缺血性 MACE

Cardio-Oncology 安全警示 (17 RCT 統合)

Pick #4 — 設計與結果

Alexandre J, et al. *Eur Heart J* 2026 Aug 8.

 DOI: [10.1093/eurheartj/ehag613](https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehag613)

- 系統性回顧 + 統合：**17 個 Phase 3 RCT、6,799 位 B 細胞惡性腫瘤**
- ibrutinib 77.2%、acalabrutinib 13.5%、zanubrutinib 9.3%
- 主要終點：非致命缺血性 MACE（心肌缺血 + 缺血性中風/TIA）

終點	數值
非致命缺血性 MACE	RR 1.66 (1.09–2.53) , p=.02
異質性	I ² =70% (不同 BTK-I 世代)



 Scan DOI

Pick #4 — 臨床啟示

BTK-I 不只增加房顫與出血，還與缺血性動脈血栓事件相關

- 典型 cardio-oncology 安全訊號 (ibrutinib 已知增房顫/高血壓/出血)
- CLL／淋巴瘤合併心血管風險者：**選藥 + 共病管理**與血液腫瘤科共同決策
- 新一代 acalabrutinib/zanubrutinib 心血管毒性可能較低（需更多資料）
- 務實界限： $I^2=70\%$ 高異質性、以 ibrutinib 為主；基於不良事件通報

Pick #5

AI 心電圖篩檢恰加斯病

巴西遠距心臟網路前瞻研究

Pick #5 — 設計與結果

Ribeiro ALP, et al. *Circulation* 2026 Aug 11.

 DOI: [10.1161/CIRCULATIONAHA.125.078949](https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.125.078949)

- 前瞻，巴西 Minas Gerais 遠距網路、107 市鎮；**n=59,154** 可得 AI-ECG-EPI 模型
- 模型 = AI 心電圖 (AI-ECG) + 3 題流行病學問卷；加權盛行率 **12.2%**

指標	AI-ECG-EPI	問卷	單純 AI-ECG
判別力 AUC	0.776	0.70	0.645

靈敏度 34.3%、特異度 91.6% (設計偏特異度、避免過度轉介)



 Scan DOI

Pick #5 — 臨床啟示

AI 心電圖 + 極簡問卷 + 遠距網路 = 可規模化的機會性篩檢範式

- 恰加斯病於台灣非本土，但**方法學普世適用**
- 可移植到台灣本土需求：AI-ECG 篩檢左心室功能、AF、瓣膜病
- 作為「機會性篩檢」而非確診工具（靈敏度僅 34%）



TAVI Section

結構性主動脈瓣方向

日本低風險真實世界 × 高齡衰弱 × 鈣化評分

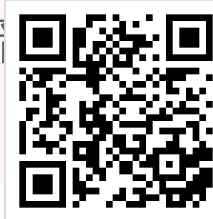
TAVI #1 — 日本低風險真實世界 TAVR vs SAVR

Takahashi K, et al. *Cardiovasc Interv Ther* 2026 Aug 12. (CURRENT AS Registry-2)

 DOI: [10.1007/s12928-026-01301-2](https://doi.org/10.1007/s12928-026-01301-2)

- 低 STS 分數、非透析重度主動脈瓣狹窄 (Aortic Stenosis, AS) ; 配對後 TAVR 162 vs 外科主動脈瓣置換 (SAVR) 162
- 主要終點 (全因死亡 + 致殘中風 + 心衰住院) **3 年 19.5% vs 17.4% (p=0.82)** ; 校正 **HR 1.05 (0.50–2.20)**

 **實際臨床選擇下，低風險 TAVR 與 SAVR 三年硬終點相當——對台灣（東亞、體型解剖相近）heart team 決策具參照；耐久性仍需更長追蹤**



 Scan DOI

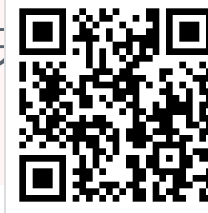
TAVI #2 — 高齡 TAVR：衰弱預測五年死亡

Huet J, et al. *J Am Geriatr Soc* 2026 Aug 12.

 DOI: [10.1111/jgs.70660](https://doi.org/10.1111/jgs.70660)

- 法國 Nantes、 ≥ 75 歲 TAVR 976 例；中位 84 歲，**5 年死亡率 46%**
- **臨床衰弱量表 (Clinical Frailty Scale, CFS)** 是唯一獨立預測因子：**HR 1.12 (1.01–1.26)**
- 5 年死亡：健壯 38% → 重度衰弱 55% ($p=0.005$)

 TAVR 決策不能只看心血管參數——**術前納入 CFS 衰弱評估**，結合心臟科與老年醫學追蹤



 Scan DOI

TAVI #3 — 術前鈣化：130 HU 就夠

Welt M, et al. *Int J Cardiovasc Imaging* 2026 Aug 14.

 DOI: [10.1007/s10554-026-03800-y](https://doi.org/10.1007/s10554-026-03800-y)

- 63 例三葉瓣高流量/高壓差重度 AS；於 130–1000 HU 量化 CT 主動脈瓣鈣化 (CT-AVC)
- 各門檻 CT-AVC 皆與 gradient 相關；但**辨別極嚴重血流負荷各門檻相當 (AUC 0.65–0.67 , DeLong p=0.68)**

 **沿用標準 130 HU Agatston 即可**，更高 HU 門檻未增加辨別力；高門檻應視為補充性度分析。屬單中心小樣本



 Scan DOI



TEER Section

二尖瓣與三尖瓣緣對緣

≥85 歲 M-TEER × T-TEER 縮縫隙新概念 × 裝置 IE

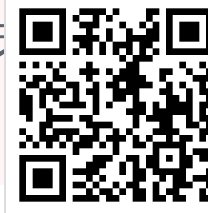
TEER #1 — ≥85 歲的 PASCAL M-TEER

Jürgens F, et al. *Catheter Cardiovasc Interv* 2026 Aug 12.

 DOI: [10.1002/ccd.70807](https://doi.org/10.1002/ccd.70807)

- Essen 單中心、PASCAL 二尖瓣緣對緣修復 (M-TEER) ; ≥85 歲 71 例 (平均 87 歲) vs <85 歲 304 例
- **無任何葉片損傷/單葉脫位/裝置相關併發症** ; 30 天 ≥85 歲組零死亡
- 中期 (中位 430 天) 總死亡 **5.6% vs 7.6% (p=0.76)**

 **≥85 歲不應成為 M-TEER 排除理由**——以生理年齡與衰弱、而非實足年齡篩選 ; 台灣社會需求上升



 Scan DOI

TEER #2 — T-TEER 大縫隙：從上方縮合縫隙

Vincent F, Coisne A. *JACC Case Rep* 2026;31(32):109211.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109211](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109211)

- 針對**大接合縫隙 (coaptation gap)** 使三尖瓣緣對緣修復 (T-TEER) 難以夾合的病灶
- 概念：**術中暫時性下腔靜脈 (Inferior Vena Cava, IVC) 阻塞** → 減少右心回流/改變幾何 → **縮小三尖瓣接合縫隙**

 縫隙過大是 T-TEER 失敗主因之一；此「從上方縮縫隙」概念為邊緣解剖病人多一種術中 bailout。屬概念性評論，待系列驗證



 Scan DOI

TEER #3 — 結構瓣膜介入後的感染性心內膜炎

Płońska-Gościński E, et al. *Kardiologia Polska* 2026 Aug 12. (波蘭專家共識)

 DOI: [10.33963/v.phj.113648](https://doi.org/10.33963/v.phj.113648)

- **TAVI 相關感染性心內膜炎 (Infective Endocarditis, IE)** 約 0.3–2.0 / 100 人年，死亡率高；TEER 相關 IE 較少但預後同樣不佳
- 表現常不典型；**超音波陰性不能排除** → **善用心臟 CT/PET**；符合適應症者仍應考慮手術

 隨介入量上升，裝置相關 IE 絕對數會增加：對術後不明發燒/栓塞/心衰高度警覺，建立診斷與轉介流程



Honorable Mentions

其他值得一讀

其他值得一讀 (1/2)

研究	期刊	重點	連結
AF + 阿茲海默症抗凝 (瑞典)	<i>Eur Heart J</i>	NOAC 認知退化較慢 (MMSE +0.23/年)、死亡 HR 0.81、缺血性中風/栓塞 HR 0.66，大出血未增	DOI PMID
子宮內膜異位症 × VTE (丹麥)	<i>Eur Heart J</i>	64k vs 256k ; VTE 校正 HR 1.52 (DVT 1.50、PE 1.52)	DOI PMID
亞洲 T2D 的 AMI 蛋白體 (SMART2D)	<i>JACC Asia</i>	17 蛋白與 MI 相關 ; 8 蛋白面板改善分類 ; MR 指向 FGF5	DOI PMID

其他值得一讀 (2/2)

研究	期刊	重點	連結
AI-ECG 監測 mavacamten (ECG-Vision)	Circ Heart Fail	阻塞型 HCM 預測左心室功能不良 AUC 0.94、NPV 100% → 減少追蹤超音波負擔	DOI PMID
Valvosoft 非侵入性超音波治療 AS	Circulation	體外聚焦超音波軟化鈣化瓣、改善血流動力學 (早期樞紐資料)	DOI PMID
單細胞多體學 × 免疫風險 (LURIC)	Eur Heart J	獨立於 hsCRP/IL-6 的 T 細胞增殖特徵與冠心病及預後相關，多世代重現	DOI PMID



Case Reports

結構／冠脈介入方向 × 5

Case #1 — 三軌抓捕：從右心室取回移位支架

Zamora P, et al. JACC Case Rep 2026 Aug 13.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109753](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109753)

大型自膨鎳鈦支架自肝靜脈移位至右心室 (RV)。標準抓捕失敗後，以 **22-F 大孔徑股靜脈 (先 preclosure)**、創新**「三軌」骨架 (1 腔內超硬 + 2 腔外 J 導線) ** 讓 GooseNeck 抓捕器重新咬住、完整取回。

 大孔徑靜脈務必事先 preclosure；跨三尖瓣防葉片纏繞/RV 穿孔；標準 resnaring 失敗時
「多軌支撐」是可複製 bailout



 Scan DOI

Case #2 — 微導管長時灌注硝酸普鈉逆轉無再流

Wang Y, et al. JACC Case Rep 2026 Aug 13.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109740](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109740)

兩例延遲就醫 (>43h) STEMI 於救援 PCI 發生**難治性無再流 (No-Reflow , TIMI 0-1)** , 反覆抽栓與 bolus 血管擴張劑無效。以動脈灌注微導管**固定 8 μ g/min 持續灌注硝酸普鈉 8-12 小時** , 安全逆轉微血管阻塞、恢復 TIMI 3、保留心室功能。

 無再流缺乏「持續、局部」標準策略；留置微導管長時定點灌注是可操作 bailout (注意全身低血壓監測)



 Scan DOI

Case #3 — 高風險 TAVR 的全身栓塞保護

Abukhalaf O, et al. JACC Case Rep 2026 Aug 12.

 DOI: [10.1016/j.jaccas.2026.109800](https://doi.org/10.1016/j.jaccas.2026.109800)

3 位高栓塞風險（主動脈瓣大血栓、左心室流出道腫塊、抗凝下持續左心房血栓）的重度 AS 病人，TAVR 中用**全身栓塞保護裝置**；皆成功、30 天無神經事件，2 例撈到碎屑（1 例病理為粥狀斑塊）。

 傳統腦栓塞保護裝置 (CEPD) 只保護部分腦血管；「全身」栓塞保護對可見血栓/腫塊的極高風險解剖或更周全。屬 3 例初體驗



 Scan DOI

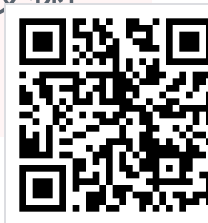
Case #4 — BACTRA：經橈球囊輔助跨瓣

Hamilton GW, et al. *Eur Heart J Case Rep* 2026;10(8):ytag536.

 DOI: [10.1093/ehjcr/ytag536](https://doi.org/10.1093/ehjcr/ytag536)

TAVI 因**嚴重迂曲**或**水平主動脈**跨瓣困難時，**BACTRA 技術**改用**經橈動脈**送入周邊球囊輔助跨瓣；兩例（球擴張瓣、自膨瓣各一）皆成功植入，**免除額外股動脈穿刺與 sheath 升級**。

 跨瓣困難常見卡關點；用橈動脈提供球囊軌道、降低血管併發症、流程精簡。屬兩例技術
示範



 Scan DOI

Case #5 — 單一 Impella 5.5 撐 276 天橋接移植

Shimamura J, et al. *Artif Organs* 2026 Aug 13.

 DOI: [10.1111/aor.70225](https://doi.org/10.1111/aor.70225)

69 歲雙心室衰竭合併心因性休克，以**單一 Impella 5.5 微軸流左心室輔助裝置 (LVAD)** 支持 **276 天** 橋接心臟移植（遠超核准的 14 天）；過程處理心律不整、腎衰竭、HIT；移植後裝置無機械損傷/血栓，術後 5 個月良好。

 Impella 5.5 通常用於急性短期；本例在多專科細緻管理下把單一裝置推到 276 天並成功橋接。機械循環支持 (MCS) 團隊的極端參考



 Scan DOI



Take Home Message

1. 量腰圍，別只看 BMI (CCC, n=259,388) — WC/WHR 再分層 9 種終點
2. 同斑塊女性 MI 較低，但阻塞性亞臨床病灶仍數倍風險 (女 4.1 / 男 12)
3. 真實世界預後可被改寫 (JROADHF-NEXT) — 死亡↓26.7%、再住院↓52.1%
4. BTK 抑制劑非心血管中性 — 缺血性 MACE RR 1.66
5. AI-ECG + 問卷 + 遠距 = 可規模化篩檢 (恰加斯 AUC 0.776)
6. TAVI：日本低風險 TAVR≈SAVR；高齡看衰弱 CFS；鈣化 130 HU 就夠
7. TEER：≥85 歲 M-TEER 安全；T-TEER 大縫隙可 IVC 阻塞縮縫；裝置 IE 善用 CT/PET

完整參考文獻 (1/2)

Top 5 Picks

1. Dardari ZA, et al. WC/WHR beyond BMI across 9 CV outcomes (CCC). *J Am Coll Cardiol* 2026;88(6):670–684.
2. Larsen AF, et al. Gender-related risk of MI & subclinical coronary atherosclerosis. *Eur Heart J* 2026.
3. Tohyama T, et al. JROADHF and JROADHF-NEXT. *Eur Heart J* 2026.
4. Alexandre J, et al. BTK inhibitors and CV risk: meta-analysis. *Eur Heart J* 2026.
5. Ribeiro ALP, et al. AI-ECG opportunistic screening for Chagas disease. *Circulation* 2026.

TAVI Section

6. Takahashi K, et al. TAVR vs SAVR low-risk real practice Japan. *Cardiovasc Interv Ther* 2026.
7. Huet J, et al. Frailty & 5-year mortality after TAVR ≥ 75 y. *J Am Geriatr Soc* 2026.
8. Welt M, et al. CT multi-threshold aortic valve calcium pre-TAVI. *Int J Cardiovasc Imaging* 2026.

完整參考文獻 (2/2)

TEER Section

9. Jürgens F, et al. M-TEER in patients >85 years. [Catheter Cardiovasc Interv](#) 2026.
10. Vincent F, Coisne A. Vena cava occlusion for coaptation-gap reduction in T-TEER. [JACC Case Rep](#) 2026.
11. Płońska-Gościński E, et al. IE after transcatheter valvular interventions. [Kardiol Pol](#) 2026.

Honorable Mentions

12. Zhu N, et al. OAC, cognition & outcomes in AF + Alzheimer's. [Eur Heart J](#) 2026.
13. Ryde HV, et al. Endometriosis & VTE. [Eur Heart J](#) 2026.
14. Gurung RL, et al. Plasma proteins & AMI in Asians with T2D (SMART2D). [JACC Asia](#) 2026.
15. Bavishi A, et al. ECG-Vision for LV dysfunction in HCM on mavacamten. [Circ Heart Fail](#) 2026.
16. Vincent F, et al. Valvsoft noninvasive ultrasound for calcific AS. [Circulation](#) 2026;154(6):587–590.
17. Horstmann H, et al. Single-cell multi-omics immune risk & CV outcomes. [Eur Heart J](#) 2026.

Case Reports

18. Zamora P, et al. Triple-Rail Snare stent retrieval from RV. [JACC Case Rep](#) 2026.
19. Wang Y, et al. Prolonged intracoronary nitroprusside for no-reflow. [JACC Case Rep](#) 2026.
20. Abukhalaf O, et al. Full-body embolic protection during TAVR. [JACC Case Rep](#) 2026.
21. Hamilton GW, et al. BACTRA technique. [Eur Heart J Case Rep](#) 2026;10(8):ytag536.
22. Shimamura J, et al. 276 days Impella 5.5 bridge to transplant. [Artif Organs](#) 2026.

縮寫對照表 (1/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
BMI	Body Mass Index	身體質量指數
WC / WHR	Waist Circumference / Waist-to-Hip Ratio	腰圍／腰臀比
CCC	Cross-Cohort Collaboration	跨世代合作聯盟
MI / AMI	(Acute) Myocardial Infarction	(急性) 心肌梗塞
CCTA	Coronary CT Angiography	冠狀動脈電腦斷層血管攝影
HR / RR / OR	Hazard / Risk / Odds Ratio	風險比／相對風險／勝算比
AUC / NPV	Area Under Curve / Negative Predictive Value	曲線下面積／陰性預測值
HF / HF _r EF / HF _p EF	Heart Failure (reduced/preserved EF)	心衰竭 (射血分數降低/保留)
GDMT	Guideline-Directed Medical Therapy	指引導向藥物治療
MRA	Mineralocorticoid Receptor Antagonist	礦皮質素受體拮抗劑
NOAC	Non-Vitamin K Oral Anticoagulant	非維生素 K 口服抗凝劑
AF	Atrial Fibrillation	心房顫動
VTE / DVT / PE	Venous Thromboembolism / DVT / Pulmonary Embolism	靜脈栓塞／深部靜脈血栓／肺栓塞
BTK-i	Bruton's Tyrosine Kinase Inhibitor	布魯頓氏酪氨酸激酶抑制劑
MACE / TIA	Major Adverse CV Events / Transient Ischemic Attack	重大不良心血管事件／短暫性腦缺血

縮寫對照表 (2/2)

縮寫	全名 (英文)	中文
AI-ECG	AI-Enabled Electrocardiogram	人工智慧心電圖
TAVI / TAVR	Transcatheter Aortic Valve Implantation / Replacement	經導管主動脈瓣植入／置換
SAVR	Surgical Aortic Valve Replacement	外科主動脈瓣置換
AS / AR	Aortic Stenosis / Regurgitation	主動脈瓣狹窄／逆流
STS	Society of Thoracic Surgeons score	胸腔外科醫學會風險分數
CFS	Clinical Frailty Scale	臨床衰弱量表
CT-AVC / HU	CT Aortic Valve Calcium / Hounsfield Unit	電腦斷層主動脈瓣鈣化／亨氏單位
TEER / M-TEER / T-TEER	Transcatheter Edge-to-Edge Repair (Mitral/Tricuspid)	經導管緣對緣修復 (二尖瓣/三尖瓣)
MR / TR	Mitral / Tricuspid Regurgitation	二尖瓣／三尖瓣逆流
IVC / RV	Inferior Vena Cava / Right Ventricle	下腔靜脈／右心室
CEPD	Cerebral Embolic Protection Device	腦栓塞保護裝置
IE / PET	Infective Endocarditis / Positron Emission Tomography	感染性心內膜炎／正子斷層造影
HCM / LVSD	Hypertrophic Cardiomyopathy / LV Systolic Dysfunction	肥厚型心肌病／左心室收縮功能不良
STEMI / PCI / TIMI	ST-Elevation MI / Percutaneous Coronary Intervention / TIMI flow	ST 上升型 MI／經皮冠狀動脈介入／TIMI 血流
MCS / LVAD	Mechanical Circulatory Support / LV Assist Device	機械循環支持／左心室輔助裝置
PCSK9 / LDL-C	Proprotein Convertase Subtilisin-Kexin 9 / LDL Cholesterol	PCSK9／低密度脂蛋白膽固醇

謝謝聆聽

Q & A

讀書會共筆整理人：謝慕揚 MD, PhD, FESC

心臟內科 | 結構性心臟病介入

本文件為讀書會共筆之教學整理，
僅供醫療專業同仁臨床教學交流參考。